GRATIS-LERNHILFE · PRAXIS

Handgriffe Schritt für Schritt

Von der Infusion über die s.c.-Injektion bis zur Reanimation: 17 Pflegehandgriffe mit Bildern zu jedem Schritt, Merksatz und Quizfragen.

Bestehen ist planbar.

Infusion · Injektion · Vitalzeichen · Notfall · Prophylaxen · Hygiene

17	99	51
Handgriffe	Schritte mit Bild	Quizfragen

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Praxis. Es gelten immer die ärztliche Anordnung, der Hygieneplan und die Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

1 Infusion vorbereiten

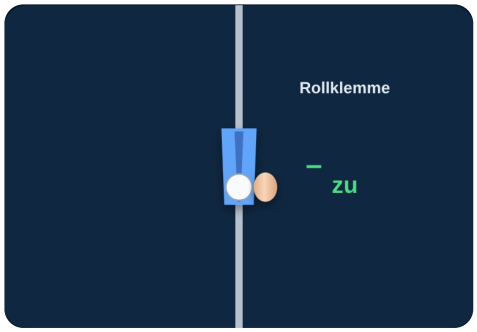
Schwerkraftinfusion richten, entlüften, beschriften · 7 Schritte



SCHRITT 1

Prüfen

Hände desinfizieren. Anordnung prüfen. Infusionslösung kontrollieren: **richtige Lösung, Verfallsdatum, Verpackung unversehrt, Lösung klar**.



SCHRITT 2

Rollklemme schließen

Infusionssystem auspacken und die **Rollklemme schließen**, bevor du es anschließt.



SCHRITT 3

Einstichstelle desinfizieren

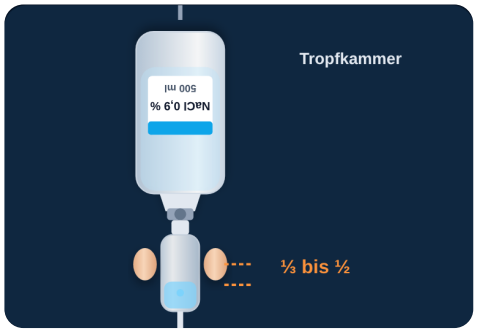
Schutzkappe entfernen. Das Einstichseptum **desinfizieren** und die **Einwirkzeit** abwarten.



SCHRITT 4

Dorn einstechen

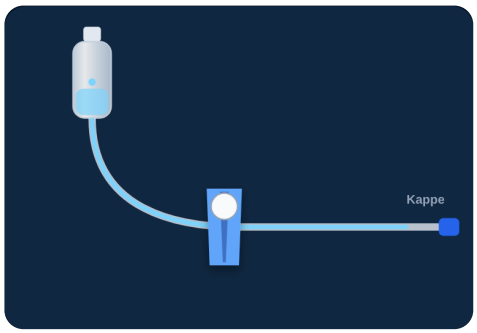
Den Dorn des Systems **gerade** in das Septum stechen, **ohne ihn zu berühren**.



SCHRITT 5

Tropfkammer füllen

Infusion aufhängen. Tropfkammer zusammendrücken, bis sie zu **⅓ bis ½** gefüllt ist.



SCHRITT 6

System luftfrei füllen

Rollklemme **langsam öffnen**, bis die Leitung luftfrei gefüllt ist. Dann wieder **schließen**. Schutzkappe am Ende bleibt drauf.



SCHRITT 7

Beschriften

Infusion beschriften: **Name des Patienten, Datum & Uhrzeit, Zusätze mit Dosis, Handzeichen**. Hausstandard beachten.

Merke: Tropfkammer ⅓ bis ½ füllen – zu voll: keine Tropfen zählbar, zu leer: Luft im System.

TESTE DICH

1. Wie weit füllst du die Tropfkammer?
   A) Komplett voll · B) Zu ⅓ bis ½ · C) Gar nicht · D) Nur einen Tropfen
2. Was schließt du, bevor du das System anschließt?
   A) Die Rollklemme · B) Nichts · C) Den Beutel · D) Die Belüftung am Patienten
3. Was gehört NICHT auf die Beschriftung?
   A) Datum und Uhrzeit · B) Zusatz mit Dosis · C) Handzeichen · D) Die Diagnose des Patienten

2 Subkutane Injektion

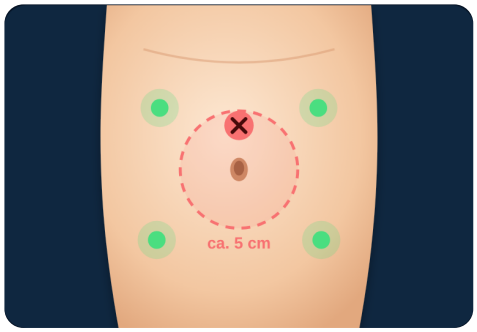
z. B. Heparin oder Insulin mit Fertigspritze · 7 Schritte



SCHRITT 1

Anordnung prüfen

Hände desinfizieren. Nach den **R-Regeln** prüfen: richtiger Patient, Wirkstoff, Dosis, Applikationsart, Zeitpunkt.



SCHRITT 2

Einstichstelle wählen

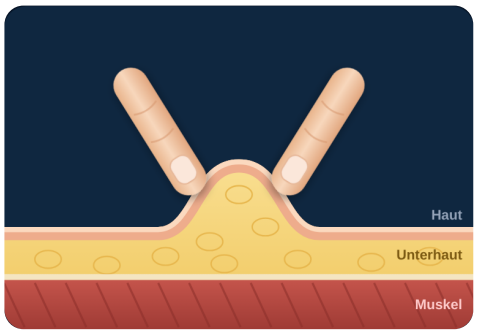
Am Bauch mit **Abstand zum Nabel** (ca. 5 cm) oder am Oberschenkel außenvorne. **Stellen wechseln**, keine Hämatome oder Narben.



SCHRITT 3

Haut desinfizieren

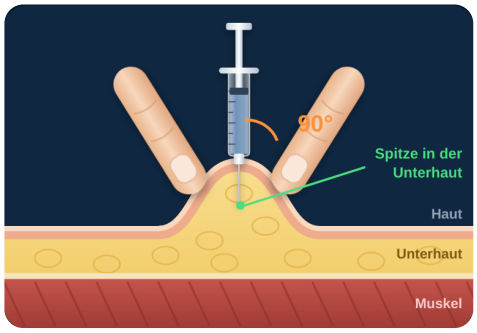
Hautdesinfektion auftragen und die **Einwirkzeit** nach Herstellerangabe abwarten. Danach nicht mehr berühren.



SCHRITT 4

Hautfalte bilden

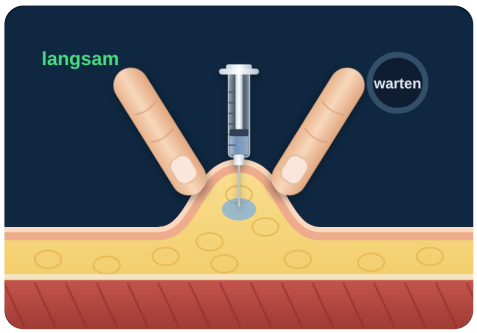
Mit Daumen und Zeigefinger eine **Hautfalte** abheben und halten.



SCHRITT 5

Einstechen

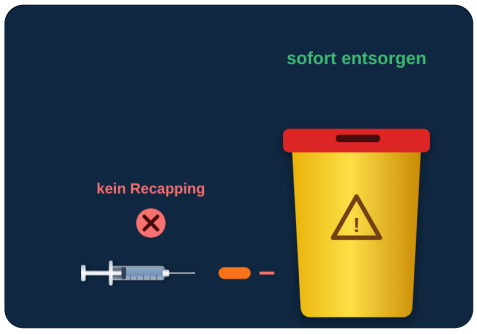
Nadel zügig im **90°-Winkel** in die Hautfalte stechen. Bei sehr schlanken Menschen ggf. 45° (Hausstandard). **Nicht aspirieren.**



SCHRITT 6

Langsam injizieren

Langsam injizieren. Bei Pens die Nadel nach Herstellerangabe noch **einige Sekunden** stehen lassen. Dann Nadel herausziehen und Hautfalte loslassen.



SCHRITT 7

Entsorgen

Kanüle **sofort** in den Abwurfbehälter. **Kein Recapping.** Einstichstelle nicht massieren. Dokumentieren.

Merke: Hautfalte, 90°, nicht aspirieren, nicht massieren, Kanüle sofort in den Abwurf.

TESTE DICH

1. In welchem Winkel stichst du bei normaler Hautfalte meist ein?
   A) 15° · B) 90° · C) 180° · D) Egal
2. Aspirierst du bei der s.c.-Injektion?
   A) Ja, immer · B) Nur bei Insulin · C) Nein · D) Nur am Oberschenkel
3. Was machst du nach einer Heparin-Injektion NICHT?
   A) Die Einstichstelle massieren · B) Die Kanüle in den Abwurfbehälter · C) Dokumentieren · D) Die Hände desinfizieren

3 Hygienische Händedesinfektion

Einreiben in 30 Sekunden – mit Fingerkuppen & Daumen · 8 Schritte



SCHRITT 1

Genug Mittel

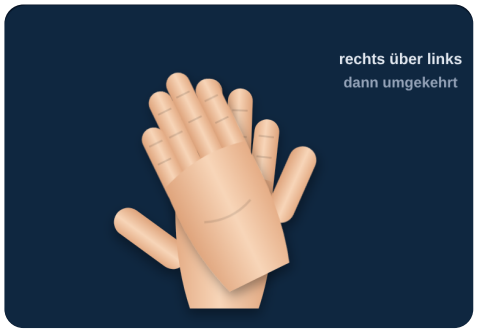
Hände sind **trocken**, ohne Schmuck. Die hohle Hand mit Desinfektionsmittel füllen (ca. **3–5 ml**).



SCHRITT 2

Handfläche auf Handfläche

Handflächen aneinander reiben.



SCHRITT 3

Handrücken

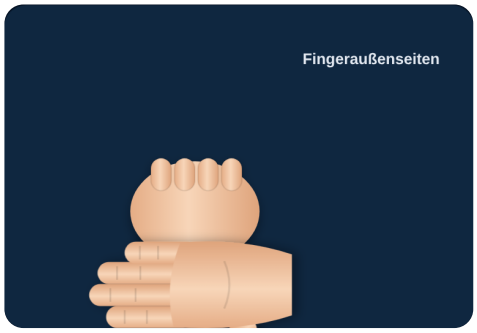
Rechte Handfläche über den linken Handrücken – dann umgekehrt.



SCHRITT 4

Finger verschränkt

Handflächen mit **verschränkten, gespreizten Fingern** aneinander reiben.



SCHRITT 5

Fingeraußenseiten

Die Außenseiten der Finger in der jeweils anderen Handfläche reiben.



SCHRITT 6

Daumen

Den **Daumen** kreisend in der geschlossenen anderen Hand reiben. Wird oft vergessen!



SCHRITT 7

Fingerkuppen

Die **Fingerkuppen** kreisend in der anderen Handfläche reiben. Ebenfalls oft vergessen!



SCHRITT 8

30 Sekunden

Das Mittel über die gesamte Einwirkzeit (meist **30 Sekunden**, Herstellerangabe) einreiben. Die Hände müssen die ganze Zeit **feucht** bleiben.

Merke: Die Reihenfolge ist nicht entscheidend – wichtig ist, dass alle Stellen 30 Sekunden benetzt sind, vor allem Fingerkuppen und Daumen.

TESTE DICH

1. Wie lange reibst du das Mittel ein (meist)?
   A) 5 Sekunden · B) 30 Sekunden · C) 2 Minuten · D) Bis der Geruch weg ist
2. Welche Stellen werden am häufigsten vergessen?
   A) Handflächen · B) Fingerkuppen und Daumen · C) Handrücken · D) Keine
3. Wie sollten die Hände vor der Desinfektion sein?
   A) Nass · B) Eingecremt · C) Trocken und ohne Schmuck · D) Mit Handschuhen

4 Blutdruck messen (manuell)

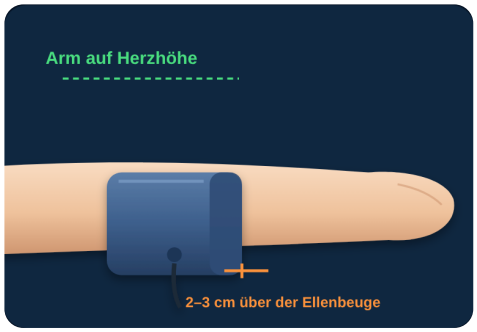
Nach Riva-Rocci mit Stethoskop · 7 Schritte



SCHRITT 1

Ruhe & Haltung

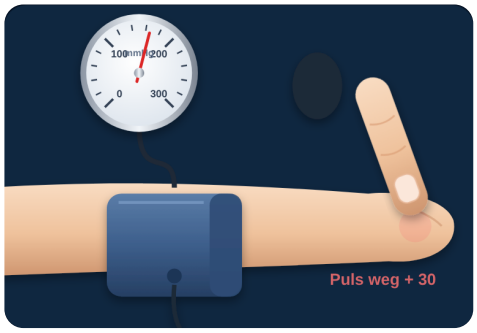
Patient sitzt oder liegt **3–5 Minuten ruhig**. Arm frei, keine einschnürende Kleidung, nicht sprechen.



SCHRITT 2

Manschette anlegen

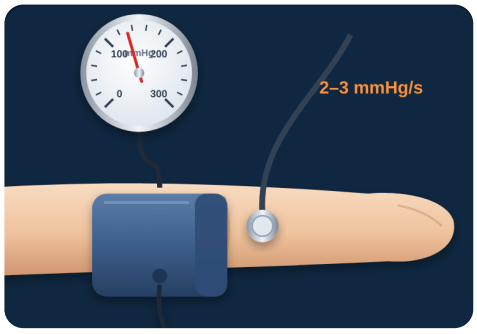
Passende **Manschettengröße** wählen. Unterkante ca. **2–3 cm über der Ellenbeuge**, Arm auf **Herzhöhe**.



SCHRITT 3

Aufpumpen

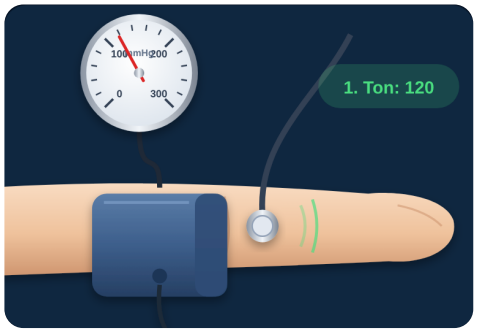
Radialispuls tasten und aufpumpen, bis der Puls **nicht mehr tastbar** ist – dann noch etwa **30 mmHg** weiter.



SCHRITT 4

Langsam ablassen

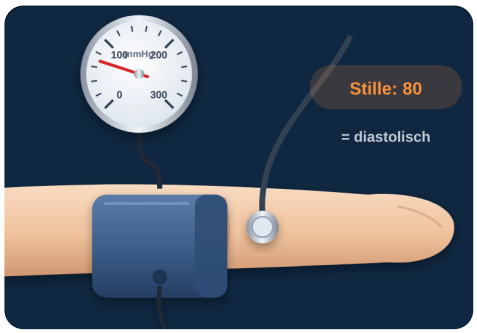
Stethoskop auf die **Ellenbeugenarterie**. Druck langsam ablassen: **2–3 mmHg pro Sekunde**.



SCHRITT 5

Erster Ton = systolisch

Der **erste hörbare Ton** ist der systolische Wert.



SCHRITT 6

Ton verschwindet = diastolisch

Wenn die Töne **verschwinden**, liest du den diastolischen Wert ab. Danach Manschette ganz entlüften.



SCHRITT 7

Dokumentieren

Wert mit **Uhrzeit, Arm und Position** dokumentieren. Auffällige Werte melden.

Merke: Manschette zu klein = Wert zu hoch, zu groß = Wert zu niedrig. Arm immer auf Herzhöhe.

TESTE DICH

1. Wie schnell lässt du den Druck ab?
   A) 10 mmHg pro Sekunde · B) 2–3 mmHg pro Sekunde · C) Alles auf einmal · D) 1 mmHg pro Minute
2. Die Manschette ist zu klein. Der Wert ist dann …
   A) zu niedrig · B) zu hoch · C) richtig · D) nicht messbar
3. Wo liegt der Arm beim Messen?
   A) Herabhängend · B) Über dem Kopf · C) Auf Herzhöhe · D) Egal

5 Blutzucker messen (kapillär)

Mit Stechhilfe und Messgerät · 6 Schritte



SCHRITT 1

Hände waschen

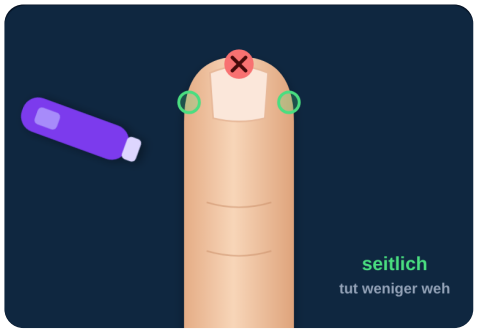
Der Patient wäscht die Hände mit **warmem Wasser** und trocknet sie gut ab. Zuckerreste an den Fingern verfälschen den Wert.



SCHRITT 2

Vorbereiten

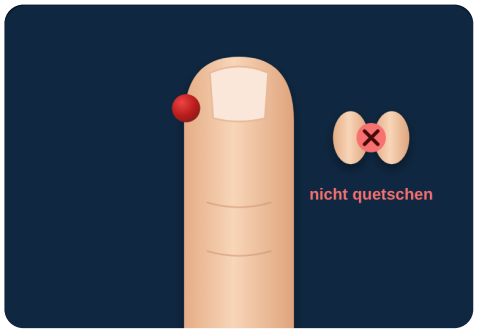
Hände desinfizieren, **Handschuhe** anziehen. Teststreifen ins Messgerät, Stechhilfe bereit.



SCHRITT 3

Seitlich stechen

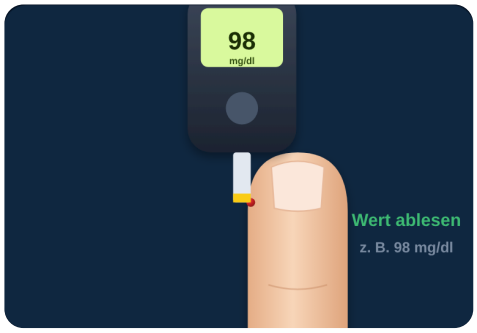
Seitlich an der Fingerbeere stechen – dort tut es weniger weh. Finger wechseln.



SCHRITT 4

Nicht quetschen

Blutstropfen entstehen lassen, **nicht quetschen** – sonst mischt sich Gewebeflüssigkeit bei. Ersten Tropfen nach Hausstandard abwischen.



SCHRITT 5

Tropfen an den Streifen

Tropfen an den Teststreifen halten, er saugt das Blut auf. Wert ablesen.



SCHRITT 6

Abschließen

Tupfer auf die Einstichstelle. Lanzette in den **Abwurfbehälter**, Handschuhe aus, Hände desinfizieren, Wert dokumentieren.

Merke: Nicht quetschen und keine Zuckerreste an den Fingern – beides verfälscht den Wert.

TESTE DICH

1. Wo stichst du am Finger?
   A) Mitten auf die Fingerbeere · B) Seitlich an der Fingerbeere · C) Am Nagel · D) In der Handfläche
2. Warum nicht quetschen?
   A) Es tut mehr weh · B) Gewebeflüssigkeit verfälscht den Wert · C) Das Gerät geht kaputt · D) Es dauert länger
3. Wohin mit der Lanzette?
   A) In den Müllbeutel · B) In den Abwurfbehälter · C) Auf das Tablett · D) Zurück in die Verpackung

6 Reanimation (Erwachsene)

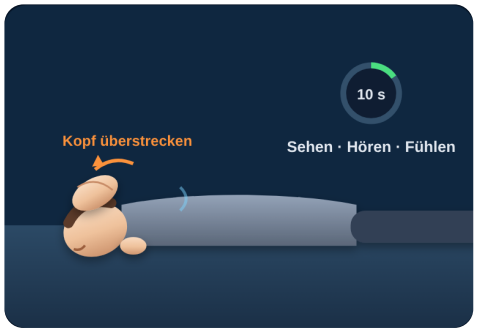
Basismaßnahmen: prüfen, rufen, drücken · 7 Schritte



SCHRITT 1

Ansprechen

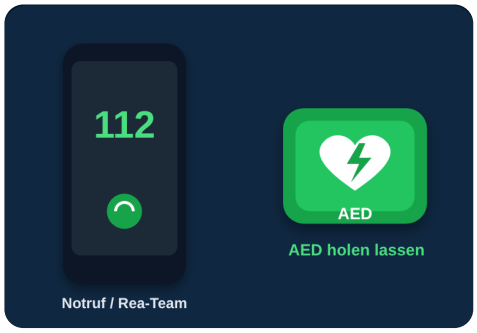
Laut ansprechen und an den Schultern rütteln. **Keine Reaktion?** Weiter.



SCHRITT 2

Atmung prüfen

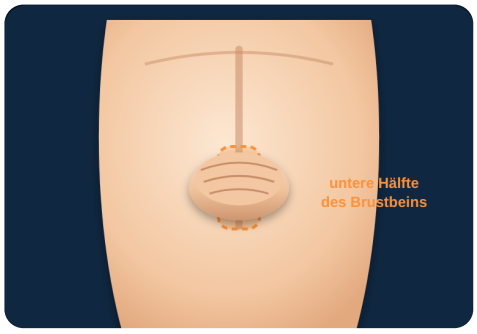
Atemwege frei machen (Kopf überstrecken) und **höchstens 10 Sekunden** prüfen: Sehen, Hören, Fühlen. Keine normale Atmung = Reanimation.



SCHRITT 3

Hilfe rufen

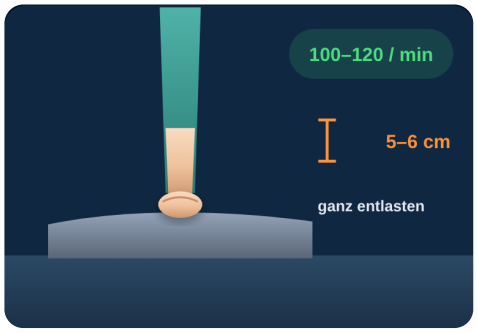
Notruf 112 bzw. im Krankenhaus das **Reanimationsteam**. **Defibrillator (AED)** holen lassen.



SCHRITT 4

Druckpunkt

Handballen auf die **Mitte des Brustkorbs** (untere Hälfte des Brustbeins), zweite Hand darauf, Arme gestreckt.



SCHRITT 5

30 × drücken

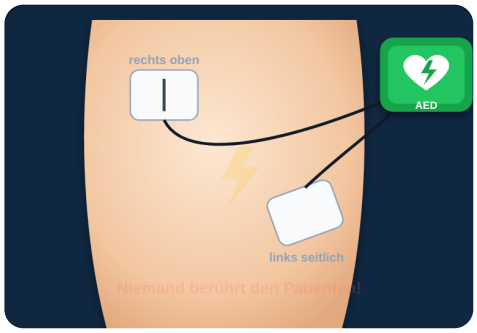
5–6 cm tief, **100–120 pro Minute**. Nach jedem Druck vollständig entlasten.



SCHRITT 6

30 : 2

Nach 30 Kompressionen **2 Beatmungen** (wenn du geschult bist und Material da ist). Sonst durchgehend drücken.



SCHRITT 7

AED nutzen

Sobald der AED da ist: einschalten, Elektroden aufkleben, den **Anweisungen folgen**. Beim Schock niemand berührt den Patienten.

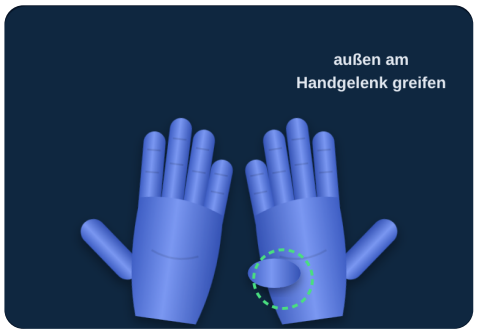
Merke: Prüfen – Rufen – Drücken: 30:2, 100–120/min, 5–6 cm, Unterbrechungen so kurz wie möglich.

TESTE DICH

1. Wie lange prüfst du die Atmung höchstens?
   A) 10 Sekunden · B) 30 Sekunden · C) 1 Minute · D) Bis der Arzt kommt
2. Wie tief drückst du beim Erwachsenen?
   A) 1–2 cm · B) 3–4 cm · C) 5–6 cm · D) 8–10 cm
3. Welches Verhältnis gilt?
   A) 15:2 · B) 30:2 · C) 5:1 · D) 30:5

7 Handschuhe richtig ausziehen

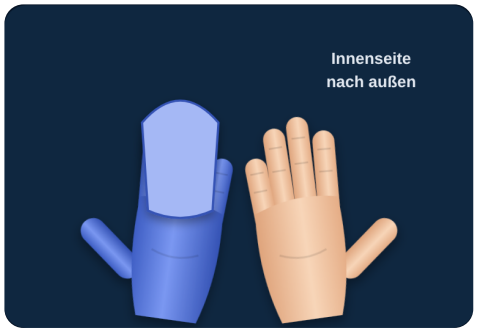
Ohne Kontakt zur Außenseite · 5 Schritte



SCHRITT 1

Am Handgelenk greifen

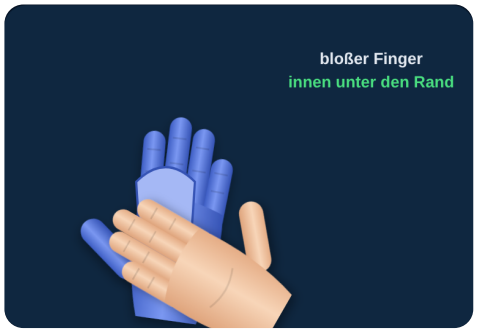
Mit der einen Hand den anderen Handschuh **außen am Handgelenk** greifen.



SCHRITT 2

Abziehen und festhalten

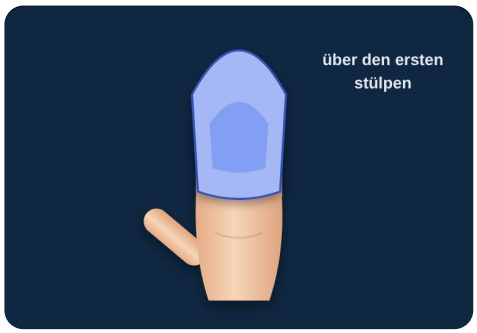
Handschuh abziehen, sodass die **Innenseite nach außen** kommt. In der behandschuhten Hand halten.



SCHRITT 3

Unter den zweiten Handschuh

Mit dem **bloßen Finger innen** unter den Rand des zweiten Handschuhs fahren – nicht außen anfassen.



SCHRITT 4

Darüber stülpen

Den zweiten Handschuh **über den ersten** stülpen und abziehen. Beide sind jetzt ineinander.



SCHRITT 5

Entsorgen & desinfizieren

Handschuhe entsorgen und **Hände desinfizieren** – Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion nicht.

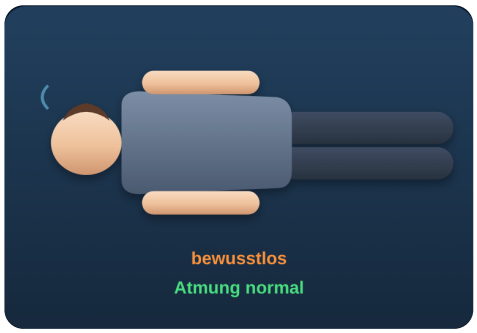
Merke: Außen nur mit Handschuh anfassen, innen nur mit bloßer Hand – danach immer Händedesinfektion.

TESTE DICH

1. Wo greifst du den ersten Handschuh?
   A) Innen · B) Außen am Handgelenk · C) An den Fingerspitzen innen · D) Gar nicht
2. Womit fasst du den zweiten Handschuh an?
   A) Mit dem bloßen Finger innen · B) Mit dem Handschuh außen · C) Mit den Zähnen · D) Mit einer Pinzette
3. Was folgt nach dem Ausziehen?
   A) Nichts · B) Hände eincremen · C) Händedesinfektion · D) Neue Handschuhe ohne Desinfektion

8 Stabile Seitenlage

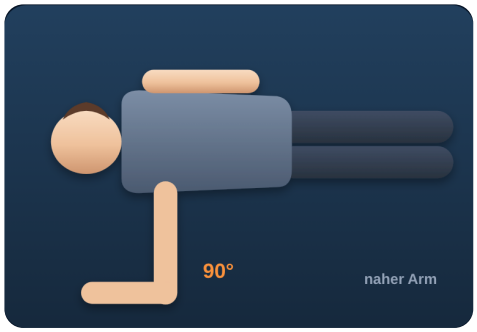
Bewusstlos, aber normale Atmung · 7 Schritte



SCHRITT 1

Wann?

Person ist **nicht ansprechbar**, atmet aber **normal**. Notruf veranlassen.



SCHRITT 2

Nahen Arm anwinkeln

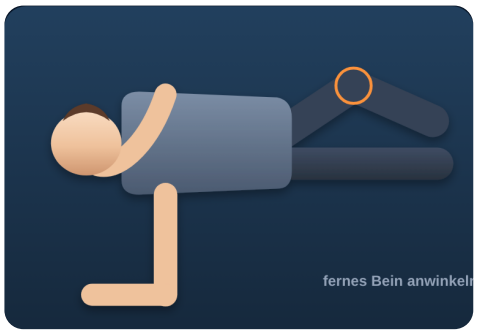
Den **nahen Arm** rechtwinklig nach oben legen, Handfläche nach oben.



SCHRITT 3

Fernen Arm zur Wange

Den **fernen Arm** über die Brust führen und den Handrücken an die **nahe Wange** halten.



SCHRITT 4

Fernes Bein anwinkeln

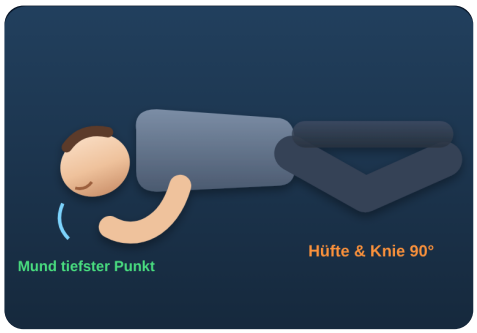
Das **ferne Bein** am Knie anwinkeln, der Fuß bleibt auf dem Boden.



SCHRITT 5

Zu dir drehen

Am **Knie und an der Schulter** fassen und die Person zu dir auf die Seite drehen.



SCHRITT 6

Kopf überstrecken

Kopf **überstrecken**, Mund leicht nach unten öffnen, damit Flüssigkeit abfließen kann. Oberes Bein so legen, dass Hüfte und Knie rechtwinklig sind.



SCHRITT 7

Atmung überwachen

Bis Hilfe kommt die **Atmung regelmäßig prüfen**. Hört sie auf: sofort Reanimation.

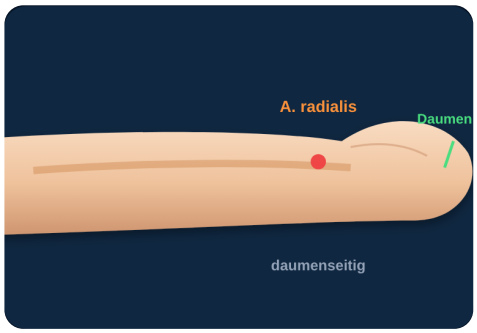
Merke: Seitenlage nur bei normaler Atmung – sonst Reanimation. Mund ist der tiefste Punkt.

TESTE DICH

1. Wann legst du in die stabile Seitenlage?
   A) Bewusstlos ohne Atmung · B) Bewusstlos mit normaler Atmung · C) Wach mit Schmerzen · D) Immer nach einem Sturz
2. Was ist der tiefste Punkt?
   A) Der Mund · B) Die Füße · C) Das Becken · D) Der Hinterkopf
3. Die Atmung setzt aus. Was tust du?
   A) Weiter warten · B) Wasser geben · C) Sofort Reanimation · D) Auf den Rücken und schlafen lassen

9 Puls messen

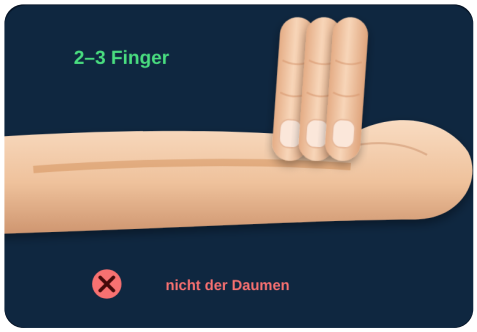
An der A. radialis: Frequenz, Rhythmus, Qualität · 5 Schritte



SCHRITT 1

Stelle finden

Puls an der **Speichenarterie** (A. radialis) tasten – daumenseitig am Handgelenk.



SCHRITT 2

Mit 2–3 Fingern

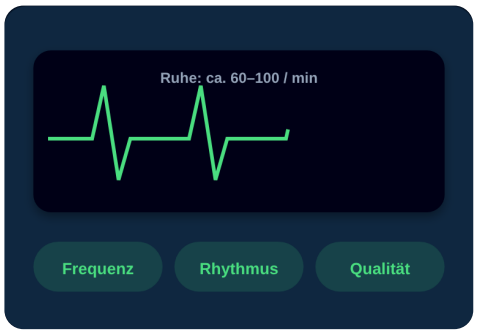
Mit **Zeige-, Mittel- und Ringfinger** leicht auflegen. **Nicht mit dem Daumen** – der hat einen eigenen Puls.



SCHRITT 3

Zählen

Bei regelmäßigem Puls **30 Sekunden** zählen und × 2. Bei **unregelmäßigem** Puls volle **60 Sekunden**.



SCHRITT 4

Beurteilen

Frequenz (Erwachsene in Ruhe ca. 60–100/min), **Rhythmus** (regelmäßig?) und **Qualität** (kräftig, schwach, fadenförmig).



SCHRITT 5

Dokumentieren

Wert dokumentieren, Abweichungen melden.

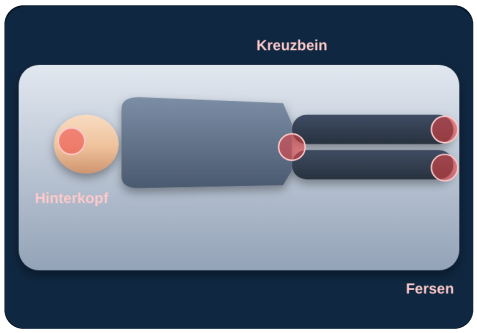
Merke: Nie mit dem Daumen tasten. Unregelmäßig = 60 Sekunden zählen.

TESTE DICH

1. Womit tastest du den Puls nicht?
   A) Zeigefinger · B) Mittelfinger · C) Daumen · D) Ringfinger
2. Der Puls ist unregelmäßig. Wie lange zählst du?
   A) 15 s × 4 · B) 30 s × 2 · C) 60 s · D) 10 s × 6
3. Was beurteilst du NICHT am Puls?
   A) Frequenz · B) Rhythmus · C) Qualität · D) Sauerstoffsättigung

10 Fingertest & 30°-Lagerung

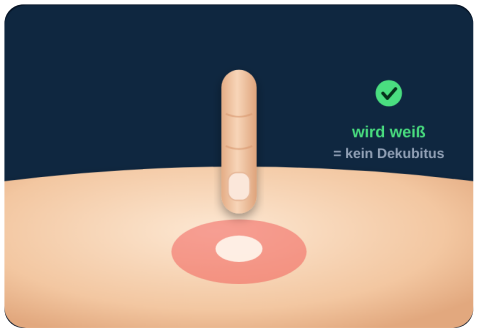
Dekubitus erkennen und vorbeugen · 5 Schritte



SCHRITT 1

Rötung prüfen

Gefährdete Stellen ansehen: **Kreuzbein, Fersen, Hüfte, Hinterkopf**.



SCHRITT 2

Fingertest

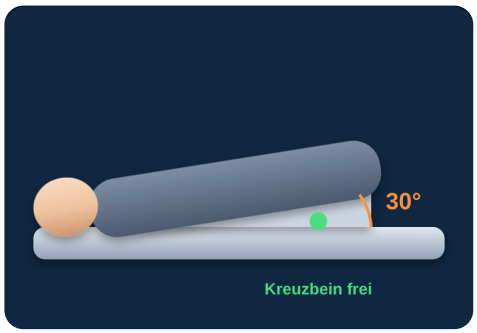
Mit dem Finger kurz auf die Rötung drücken. **Wird sie weiß**, ist es (noch) kein Dekubitus.



SCHRITT 3

Bleibt rot?

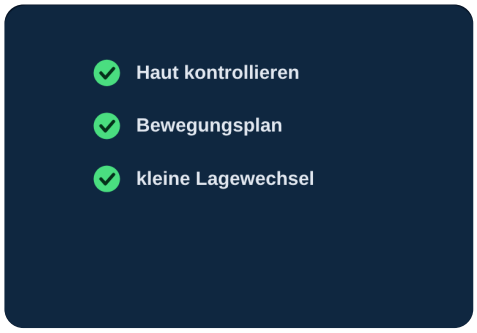
Bleibt die Rötung beim Drücken **rot**, liegt ein **Dekubitus Kategorie 1** vor: Druck entlasten, melden, dokumentieren.



SCHRITT 4

30°-Seitenlage

Ein Kissen schräg unter eine Körperseite (Rücken bis Gesäß). Das **Kreuzbein liegt frei**, der Hüftknochen auch.



SCHRITT 5

Bewegen statt Uhr

Wie oft umgelagert wird, richtet sich nach **Haut und Beweglichkeit** der Person (individueller Bewegungsplan). Kleine Positionswechsel zählen mit.

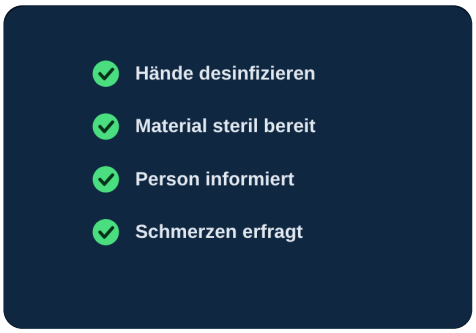
Merke: Fingertest: weiß = gut, bleibt rot = Dekubitus Kategorie 1. Bei 30° liegen Kreuzbein und Hüfte frei.

TESTE DICH

1. Die Rötung bleibt beim Fingertest rot. Das ist …
   A) normal · B) ein Dekubitus Kategorie 1 · C) eine Allergie · D) eine Verbrennung
2. Was liegt bei der 30°-Lagerung frei?
   A) Kreuzbein · B) Die Schultern · C) Die Knie · D) Gar nichts
3. Wonach richtet sich das Umlagern?
   A) Immer genau alle 2 Stunden · B) Nach Haut und Beweglichkeit der Person · C) Nur nachts · D) Nach der Uhrzeit des Arztes

11 Aseptischer Verbandwechsel

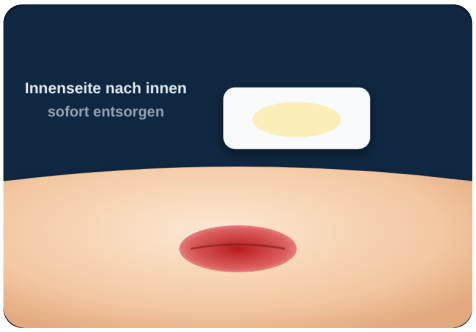
Non-Touch-Technik bei einer Wunde · 6 Schritte



SCHRITT 1

Vorbereiten

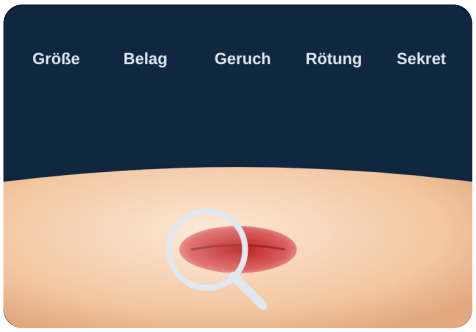
Hände desinfizieren, Material richten, Arbeitsfläche desinfizieren. Person informieren, Schmerzen erfragen.



SCHRITT 2

Alten Verband ab

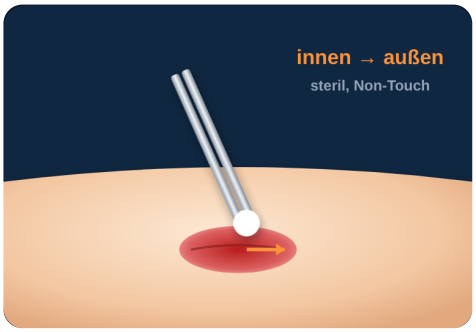
Unsterile Handschuhe, alten Verband abnehmen – Innenseite nach innen – und direkt entsorgen. Handschuhe aus, Hände desinfizieren.



SCHRITT 3

Wunde ansehen

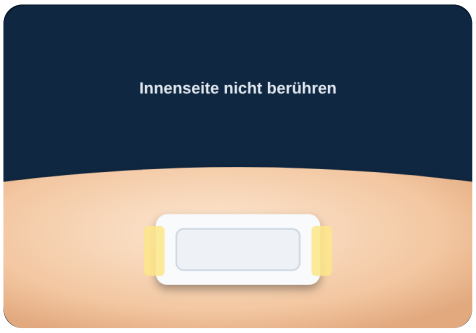
Wunde beurteilen: **Größe, Belag, Geruch, Rötung, Sekret**.



SCHRITT 4

Steril reinigen

Mit **steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen** reinigen – Wunde nicht mit unsterilen Händen berühren. Bei aseptischen Wunden **von innen nach außen**.



SCHRITT 5

Abdecken

Neue sterile Wundauflage auflegen, ohne die Innenseite zu berühren. Fixieren.



SCHRITT 6

Dokumentieren

Hände desinfizieren und Wundzustand dokumentieren (Größe, Aussehen, Material, Datum).

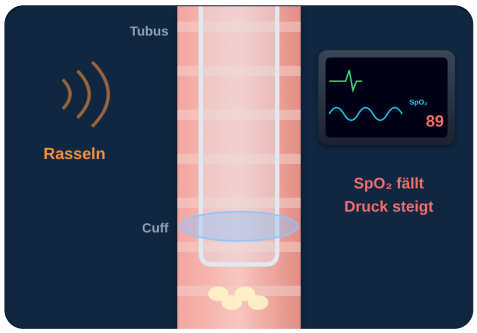
Merke: Wunde nur steril berühren. Aseptische Wunde: von innen nach außen reinigen.

TESTE DICH

1. Womit berührst du die Wunde?
   A) Mit unsterilen Handschuhen · B) Mit steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen · C) Mit der bloßen Hand · D) Gar nicht, nur pusten
2. Aseptische Wunde – Reinigungsrichtung?
   A) Von außen nach innen · B) Von innen nach außen · C) Kreuz und quer · D) Egal
3. Was passiert direkt nach dem Abnehmen des alten Verbands?
   A) Handschuhe aus, Hände desinfizieren · B) Direkt die Wunde berühren · C) Pause machen · D) Neuer Verband ohne Wechsel der Handschuhe

12 Endotracheales Absaugen

Beim intubierten oder tracheotomierten Patienten · 5 Schritte



SCHRITT 1

Notwendigkeit prüfen

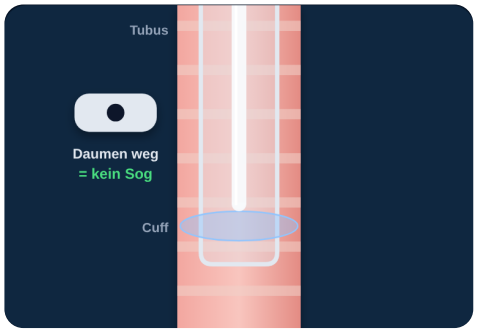
Nur bei Bedarf absaugen: **hörbares Sekret, Sättigungsabfall, steigender Beatmungsdruck**.



SCHRITT 2

Vorbereiten

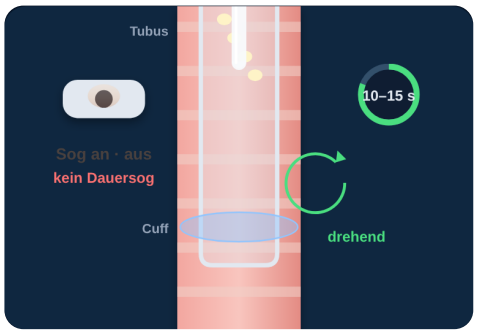
Material bereit, Sog nach Hausstandard einstellen, ggf. **präoxygenieren**. Hände desinfizieren.



SCHRITT 3

Ohne Sog einführen

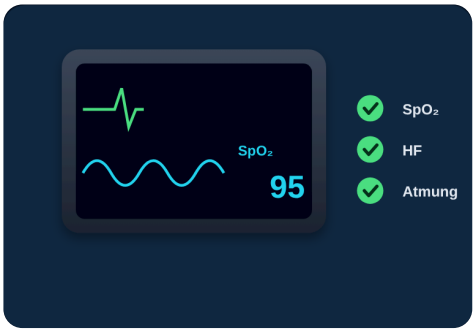
Sterilen Katheter mit **steriler Hand** einführen – dabei **kein Sog**.



SCHRITT 4

Zurückziehen – Sog nur intermittierend

Katheter **langsam drehend zurückziehen** und den Sog dabei nur **intermittierend** geben – **kein Dauersog**, sonst wird die Schleimhaut verletzt. Ein Absaugvorgang höchstens **10–15 Sekunden**.



SCHRITT 5

Patient beobachten

Während und danach **Sättigung, Herzfrequenz und Atmung** beobachten. Katheter verwerfen, dokumentieren (Menge, Farbe, Konsistenz).

Merke: Einführen ohne Sog, beim Zurückziehen Sog nur intermittierend – nie Dauersog. Höchstens 10–15 Sekunden pro Vorgang.

TESTE DICH

1. Wie gibst du den Sog beim Zurückziehen?
   A) Als Dauersog · B) Nur intermittierend · C) Schon beim Einführen · D) Gar nicht
2. Wie lange dauert ein Absaugvorgang höchstens?
   A) 10–15 Sekunden · B) 1 Minute · C) 30 Sekunden · D) So lange bis nichts mehr kommt
3. Wann saugst du ab?
   A) Fest jede Stunde · B) Bei Bedarf, z. B. hörbares Sekret · C) Nur nachts · D) Nie bei Beatmung

13 Magensonde: Lage prüfen

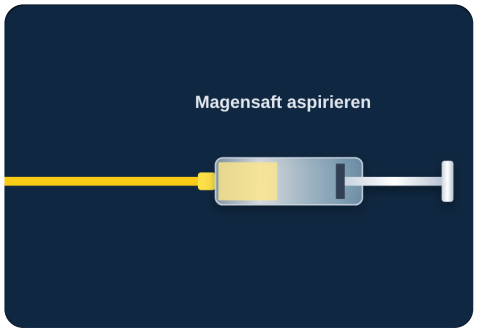
Vor jeder Gabe über die Sonde · 4 Schritte



SCHRITT 1

Markierung prüfen

Die **Markierung** an der Nase bzw. die Länge vergleichen. Ist die Sonde verrutscht?



SCHRITT 2

Aspirieren

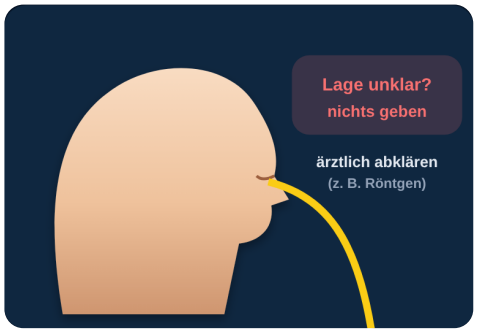
Mit einer Spritze etwas **Magensaft** ansaugen.



SCHRITT 3

pH messen

Aspirat auf einen **pH-Teststreifen**. Ein saurer Wert (Grenzwert nach Hausstandard) spricht für die Lage im Magen.



SCHRITT 4

Unsicher? Nicht geben!

Ist die Lage unklar, **nichts** über die Sonde geben und ärztlich abklären (z. B. Röntgen). Das Einblasen von Luft mit Abhören gilt nicht als sicher.

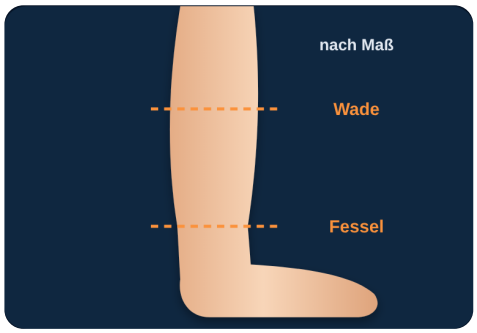
Merke: Vor jeder Gabe Lage prüfen. Unsicher = nichts geben.

TESTE DICH

1. Was spricht für die Lage im Magen?
   A) Basisches Aspirat · B) Saurer pH-Wert des Aspirats · C) Gurgeln beim Luft-Einblasen · D) Der Patient hustet
2. Die Lage ist unklar. Was tust du?
   A) Trotzdem Nahrung geben · B) Nichts geben und ärztlich abklären · C) Sonde tiefer schieben und geben · D) Wasser zum Testen geben
3. Wann prüfst du die Lage?
   A) Einmal pro Woche · B) Vor jeder Gabe · C) Nur beim Legen · D) Nie

14 Thromboseprophylaxestrümpfe

MTPS richtig anziehen · 6 Schritte



SCHRITT 1

Richtige Größe

Größe nach **Maß** (Umfang Fessel, Wade, ggf. Oberschenkel und Länge) bestimmen.



SCHRITT 2

Morgens, im Liegen

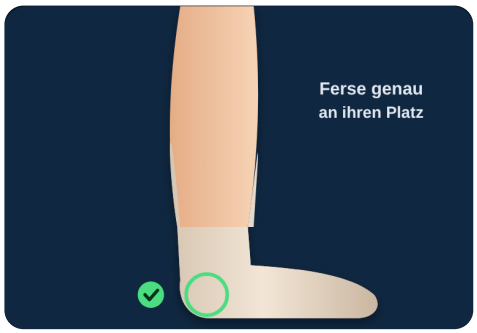
Am besten **morgens vor dem Aufstehen** anziehen, wenn die Beine noch nicht geschwollen sind.



SCHRITT 3

Bis zur Ferse umstülpen

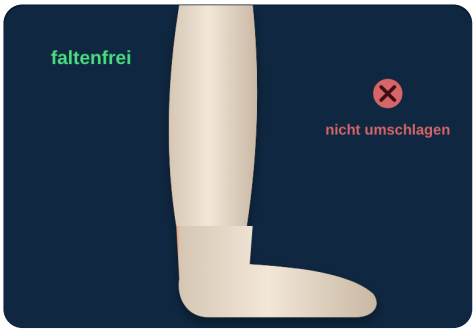
Mit der Hand in den Strumpf greifen, die Ferse fassen und den Strumpf **bis zur Ferse umstülpen**.



SCHRITT 4

Ferse genau setzen

Über den Fuß ziehen, die **Ferse genau** an ihren Platz setzen.



SCHRITT 5

Faltenfrei hochziehen

Den Rest **faltenfrei** hochziehen. **Kein Umschlagen** am Rand – das schnürt ein.



SCHRITT 6

Täglich kontrollieren

Sitz und **Haut täglich** kontrollieren (Druckstellen, Durchblutung).

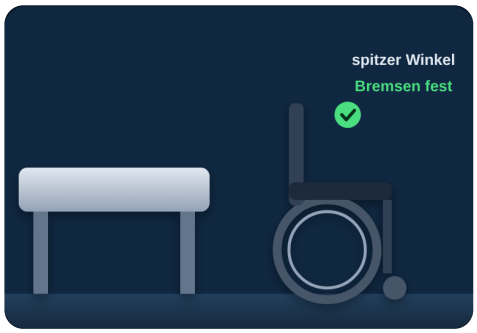
Merke: Morgens im Liegen, Ferse genau, faltenfrei – nie umschlagen.

TESTE DICH

1. Wann ziehst du MTPS am besten an?
   A) Abends · B) Morgens vor dem Aufstehen · C) Nach dem Duschen im Stehen · D) Egal
2. Was darfst du am Strumpfrand NICHT tun?
   A) Glattstreichen · B) Umschlagen · C) Kontrollieren · D) Anziehen
3. Wonach bestimmst du die Größe?
   A) Nach Schuhgröße · B) Nach Maß am Bein · C) Nach Körpergröße · D) Nach Gefühl

15 Transfer Bett → Rollstuhl

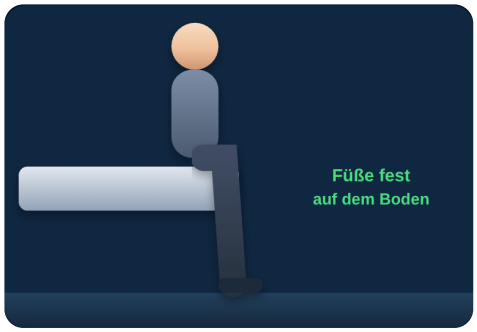
Sicher und rückenschonend · 4 Schritte



SCHRITT 1

Rollstuhl stellen

Rollstuhl im **spitzen Winkel** ans Bett, **Bremsen fest**, Fußstützen weg.



SCHRITT 2

An die Bettkante

Person an die Bettkante setzen, **Füße fest auf dem Boden**, gutes Schuhwerk.



SCHRITT 3

Gewicht nach vorn

Oberkörper **nach vorn** neigen, Gewicht über die Füße bringen. Du stützt am **Becken** – nicht unter den Achseln ziehen.



SCHRITT 4

Drehen & setzen

In **kleinen Schritten** zum Rollstuhl drehen und langsam hinsetzen lassen. Ressourcen der Person nutzen.

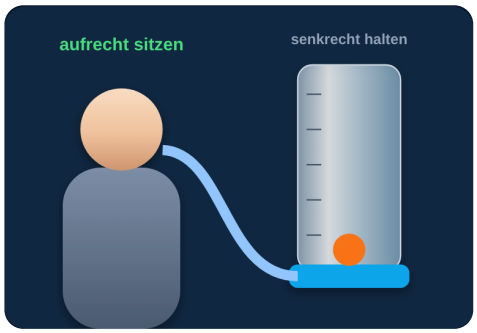
Merke: Bremsen fest, Füße auf den Boden, Gewicht nach vorn – nie unter den Achseln ziehen.

TESTE DICH

1. Wo unterstützt du beim Transfer?
   A) Unter den Achseln · B) Am Becken · C) Am Hals · D) An den Händen ziehen
2. Was machst du vor dem Transfer am Rollstuhl?
   A) Bremsen lösen · B) Bremsen feststellen · C) Rückenlehne entfernen · D) Nichts
3. Wohin verlagert die Person ihr Gewicht zum Aufstehen?
   A) Nach hinten · B) Nach vorn über die Füße · C) Zur Seite · D) Gar nicht

16 Atemtrainer (SMI)

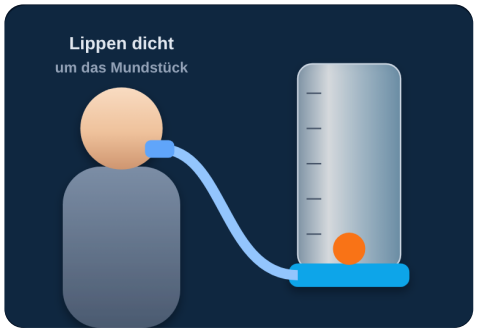
Pneumonieprophylaxe mit Incentive Spirometer · 5 Schritte



SCHRITT 1

Aufrecht sitzen

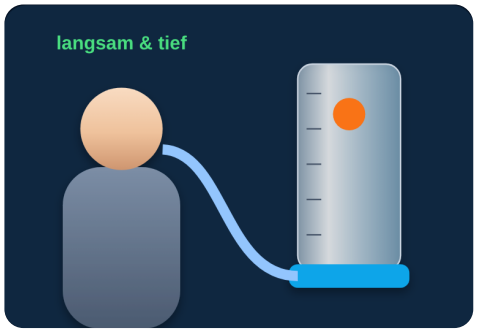
Person **aufrecht** hinsetzen, Gerät senkrecht halten.



SCHRITT 2

Ausatmen, dann ansetzen

Normal ausatmen, Mundstück mit den Lippen **dicht umschließen**.



SCHRITT 3

Langsam & tief einatmen

Langsam und tief einatmen, sodass der Kolben/die Kugel steigt.



SCHRITT 4

Kurz halten

Am Ende der Einatmung den Atem **einige Sekunden halten** (nach Hausstandard, meist ca. 3 s).

- langsam ausatmen
- kurz erholen
- wiederholen nach Anordnung

SCHRITT 5

Ausatmen & wiederholen

Langsam ausatmen, kurz erholen und mehrmals wiederholen – Anzahl und Häufigkeit nach Anordnung.

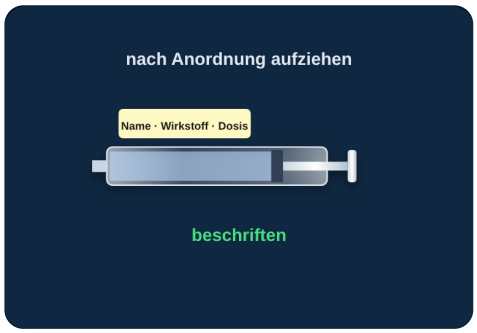
Merke: Langsam und tief einatmen, oben kurz halten – nicht stoßartig.

TESTE DICH

1. Wie wird beim SMI-Trainer eingeatmet?
   A) Schnell und stoßartig · B) Langsam und tief · C) Gar nicht · D) Nur durch die Nase
2. Was passiert am Ende der Einatmung?
   A) Sofort ausatmen · B) Atem kurz halten · C) Husten · D) Gerät schütteln
3. Wozu dient der Atemtrainer?
   A) Thromboseprophylaxe · B) Pneumonieprophylaxe · C) Dekubitusprophylaxe · D) Sturzprophylaxe

17 Perfusor vorbereiten

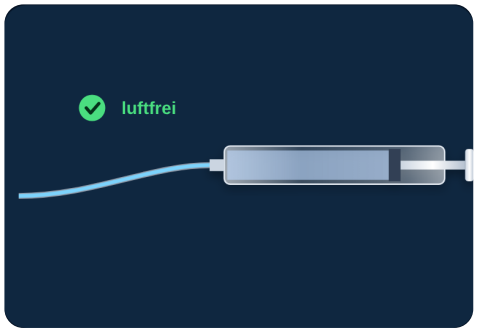
Spritze einlegen und Laufrate einstellen · 5 Schritte



SCHRITT 1

Spritze richten

Medikament nach **Anordnung** aufziehen und verdünnen, Spritze **beschriften**.



SCHRITT 2

Leitung entlüften

Perfusorleitung anschließen und **luftfrei füllen**.



SCHRITT 3

Einlegen

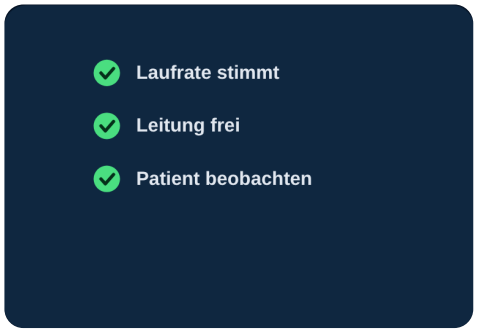
Spritze in die Halterung legen, **Kolbenhalter fixieren**, den angezeigten **Spritzentyp bestätigen**.



SCHRITT 4

Laufrate eingeben

Laufrate in **ml/h** laut Anordnung eingeben (Rechnung im Vier-Augen-Prinzip prüfen).



SCHRITT 5

Starten & kontrollieren

An den Zugang anschließen, starten. **Laufrate, Leitung und Patient** regelmäßig kontrollieren.

Merke: Es gilt ausschließlich die ärztliche Anordnung. Laufrate immer im Vier-Augen-Prinzip prüfen.

TESTE DICH

1. Was bestätigst du nach dem Einlegen der Spritze?
   A) Den Spritzentyp · B) Die Uhrzeit · C) Den Stationsnamen · D) Nichts
2. In welcher Einheit stellst du die Laufrate ein?
   A) ml/h · B) mg/kg · C) Tropfen/min · D) mmHg
3. Wonach richtet sich die Laufrate?
   A) Nach Gefühl · B) Nach der ärztlichen Anordnung · C) Nach dem letzten Patienten · D) Nach der Spritzengröße

Lösungen

1. Infusion vorbereiten: 1) B – Zu ⅓ bis ½ · 2) A – Die Rollklemme · 3) D – Die Diagnose des Patienten

2. Subkutane Injektion: 1) B – 90° · 2) C – Nein · 3) A – Die Einstichstelle massieren

3. Hygienische Händedesinfektion: 1) B – 30 Sekunden · 2) B – Fingerkuppen und Daumen · 3) C – Trocken und ohne Schmuck

4. Blutdruck messen (manuell): 1) B – 2–3 mmHg pro Sekunde · 2) B – zu hoch · 3) C – Auf Herzhöhe

5. Blutzucker messen (kapillär): 1) B – Seitlich an der Fingerbeere · 2) B – Gewebeflüssigkeit verfälscht den Wert · 3) B – In den Abwurfbehälter

6. Reanimation (Erwachsene): 1) A – 10 Sekunden · 2) C – 5–6 cm · 3) B – 30:2

7. Handschuhe richtig ausziehen: 1) B – Außen am Handgelenk · 2) A – Mit dem bloßen Finger innen · 3) C – Händedesinfektion

8. Stabile Seitenlage: 1) B – Bewusstlos mit normaler Atmung · 2) A – Der Mund · 3) C – Sofort Reanimation

9. Puls messen: 1) C – Daumen · 2) C – 60 s · 3) D – Sauerstoffsättigung

10. Fingertest & 30°-Lagerung: 1) B – ein Dekubitus Kategorie 1 · 2) A – Kreuzbein · 3) B – Nach Haut und Beweglichkeit der Person

11. Aseptischer Verbandwechsel: 1) B – Mit steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen · 2) B – Von innen nach außen · 3) A – Handschuhe aus, Hände desinfizieren

12. Endotracheales Absaugen: 1) B – Nur intermittierend · 2) A – 10–15 Sekunden · 3) B – Bei Bedarf, z. B. hörbares Sekret

13. Magensonde: Lage prüfen: 1) B – Saurer pH-Wert des Aspirats · 2) B – Nichts geben und ärztlich abklären · 3) B – Vor jeder Gabe

14. Thromboseprophylaxestrümpfe: 1) B – Morgens vor dem Aufstehen · 2) B – Umschlagen · 3) B – Nach Maß am Bein

15. Transfer Bett → Rollstuhl: 1) B – Am Becken · 2) B – Bremsen feststellen · 3) B – Nach vorn über die Füße

16. Atemtrainer (SMI): 1) B – Langsam und tief · 2) B – Atem kurz halten · 3) B – Pneumonieprophylaxe

17. Perfusor vorbereiten: 1) A – Den Spritzentyp · 2) A – ml/h · 3) B – Nach der ärztlichen Anordnung

Alle Handgriffe gibt es animiert in der PLAN-App unter Wissen → „Handgriffe animiert“ – zusammen mit 2.000+ Prüfungsfragen fürs Examen.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**